

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERTOLONGAN PERSALINAN RISIKO RENDAH		
	No. Dokumen 571.8/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2022	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Penatalaksanaan pertolongan persalinan resiko rendah		
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan pertolongan persalinan resiko rendah untuk mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. 2. Agar tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standart yang berlaku		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan bidan.		
Prosedur	1. Persiapan Alat, meliputi : 1. Partus set berisi : a. 2 klem Kelly b. Gunting tali pusat c. Benang tali pusat d. Kateter nelaton e. Gunting Episiotomi f. Klem ½ kocker g. 2 pasang sarung tangan DTT/steril h. Kasa (untuk membersihkan jalan nafas bayi) i. Gulungan kapas basah (menggunakan air DTT) 2. Spuit suntik 2 ½ atau 3 ml disposable 3. Oksitoksin 10 IU 4. Kateter penghisap De lee (penghisap lendir) atau bola karet penghisap yang baru dan bersih 5. 2 kain bersih (bisa dipersiapkan oleh keluarga) 6. 1 handuk atau kain untuk mengeringkan 7. Baju ibu 8. Celana dalam dan pembalut 9. Selimut bayi 10. Topi bayi		
Prosedur	11. Fetoskop / doppler 12. Larutan klorin 0,5 % 13. Air DTT 14. Celemek plastik 15. Perlak 16. Kantong plastik (untuk sampah) 17. Sumber air bersih yang mengalir 18. Sabun cuci tangan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERTOLONGAN PERSALINAN RISIKO RENDAH		
	No. Dokumen 571.8/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 5
	19. Detergen 20. Sikat Dekatkan Alat disamping pasien 2. Siapan klien/pasien 1. Lakukan 5 S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 2. Perkenalkan diri 3. Identifikasi pasien 4. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan 5. Bantu pasien memilih posisi yang paling nyaman 3. Siapkan lingkungan 1. Jaga <i>privacy</i> pasien dengan memasang sketsel / lampiran 2. Ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman 3. Pasang lampu sorot mengarah ke vagina 4. Laksanakan tindakan 4.1 PROSEDUR KALA I PERSALINAN RISIKO RENDAH 1. Lakukan 6 langkah cuci tangan sebelum tindakan 2. Pakai APD sesuai standar (skort, sarung tangan, sepatu boot, kaca mata google, masker) 3. Lakukan pemeriksaan fisik 4. Lakukan anamnesa 5. Lakukan inspeksi, palpasi, auskultasi 6. Lakukan periksa dalam bila ada indikasi 7. Catat hasil pemeriksaan pada status ibu 8. Lakukan pemeriksaan kemajuan persalinan setiap 4 jam 9. Lakukan observasi tensi setiap 4 jam 10. Lakukan observasi his setiap ½ jam 11. Lakukan observasi kondisi janin (DJJ, warna/bau air ketuban, molase kepala janin) setiap 4 jam 12. Lakukan observasi suhu setiap 2 jam 13. Observasi volume urine, protein dan aseton urine 14. Beri ibu nutrisi adekuat 15. Anjurkan ibu BAK setiap 2 jam sekali atau lebih sering 16. Anjurkan ibu untuk jalan-jalan		
Prosedur	4.2 PROSEDUR KALA II PERSALINAN RISIKO RENDAH 1. Dengar dan lihat adanya tanda persalinan kala II 2. Gelar handuk di atas perut ibu, patahkan ampul oxytocin, masukkan spuit steril ke dalam wadah		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERTOLONGAN PERSALINAN RISIKO RENDAH		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.8/I-SPO/MTR/VI/2025	01	3 / 5
	partus set 3. Pakai celemek plastik 4. Cuci tangan 6 langkah sebelum tindakan 5. Pakai sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk periksa dalam 6. Masukkan oxytocin ke dalam tabung suntik (gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT) 7. Bersihkan vulva dan perineum dengan kapas yang dibasahi air DTT 8. Lakukan periksa dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap. Jika selaput ketuban belum pecah lakukan amniotomi. 9. Lepas dan dekontaminasi sarung tangan dengan larutan klorin 0,5% lalu cuci tangan. 10. Periksa DJJ di saat tidak ada his 11. Beri tahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan kondisi janin. 12. Bantu ibu mendapatkan posisi meneran yang nyaman (setengah duduk) 13. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ada his dan dorongan kuat untuk meneran 14. Saat tidak ada his, anjurkan ibu untuk istirahat, beri asupan yang adekuat, nilai DJJ 15. Letakkan handuk bersih di atas perut ibu saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm 16. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 di bawah bokong ibu 17. Pakai sarung tangan pada kedua tangan 18. Lahirkan kepala 19. Cek adanya lilitan tali pusat 20. Tunggu putar paksi luar dengan sendirinya 21. Lahirkan bahu, setelah kepala lahir pegang secara biparietal dan lakukan tarikan perlahan ke arah bawah sampai bahun anterior lahir lalu ke atas untuk melahirkan bahu belakang 22. Setelah bahu lahir, lahirkan badan dan tungkai dengan cara sangga susur 23. Letakkan bayi di atas perut ibu, nilai bayi baru lahir 24. Keringkan tubuh bayi mulai muka,kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan. Ganti handuk yang sudah basah dengan selimut bayi yang bersih dan kering		
Prosedur	4.3 PROSEDUR KALA III PERSALINAN RISIKO RENDAH		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERTOLONGAN PERSALINAN RISIKO RENDAH		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.8/I-SPO/MTR/VI/2025	01	4 / 5
	1. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada janin ke 2 2. Beritahu ibu bahwa akan disuntik oxytocin agar uterus berkontraksi baik 3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir injeksikan oxytocin 10 International unit secara Intra muscular 4. Dalam waktu 2 menit klem dan potong tali pusat lalu ikat. 5. Lakukan Inisiasi Menusui dini, pastikan bayi tetap hangat, ada kontak kulit ibu dan bayi, dan pakaikan topi bayi 6. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-19 cm dari vulva 7. Lakukan peregang tali pusat terkendali dan jika placenta sudah lepas lahirkan placenta secara brand andrew 8. Lakukan masase uterus selama 15 detik atau sampai uterus berkontraksi baik dan cek kelengkapan placenta 4.4 PROSEDUR KALA VI PERSALINAN RESIKO RENDAH 1. Evaluasi adanya laserasi jalan lahir 2. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik 3. Lakukan pemeriksaan fisik BBL 4. Lanjutkan pemantauan tekanan darah, nadi, TFU, kontraksi uterus kandung kencing dan mencegah perdarahan pervaginam • 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan • Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan • Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan 5. Periksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pascapersalinan 6. Ajarkan pada ibu cara masase uterus dan menilai kontraksi 7. Estimasi jumlah perdarahan 8. Dekontaminasi alat dalam klorin 0,5% selama 10 menit 9. Buang sampah yang terkontaminasi dalam wadah yang sesuai 10. Seka ibu dengan air DTT dan bantu ibu memakai pakaian bersih 11. Dekontaminasi tempat dan celemek dengan larutan klorin 0,5% bilas dengan air mengalir 5. Membereskan alat		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERTOLONGAN PERSALINAN RISIKO RENDAH		
	No. Dokumen 571.8/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 5 / 5
	1. Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Bereskan alat-alat yang tidak digunakan 3. Cuci tangan 6 langkah setelah tindakan		
Prosedur	6. Melakukan evaluasi dan dokumentasi 1. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien 2. Dokumentasi tindakan pada rekam medik pasien		
Unit Terkait	1. IGD 2. Ruang bersalin Kandungan & Kebidanan		